

がん薬物療法(2)切除不能例

- MSI検査、RAS遺伝子検査及びBRAF^{V600E}遺伝子検査が重要
- 抗EGFR抗体薬(cetuximab, panitumumab)はRAS遺伝子野生型の大腸癌のみに適応
- BRAF^{V600E}遺伝子変異は切除不能大腸癌の約5%に認められ薬物療法の効果が乏しく予後が極めて不良
- 既治療のBRAF^{V600E}遺伝子変異大腸癌に対しては、抗EGFR抗体薬のcetuximabおよびBRAF阻害薬のencorafenib、MEK阻害薬のbinimetinibの併用療法が2次治療以降で推奨

切除不能進行・再発大腸癌の化学療法 現在

- 分子標的薬との併用が主流

- ✓ ベバシズマブ(bevacizumab) +¥274,640/月

- VEGF(: 血管内皮細胞増殖因子)に結合し、伝達を阻害

RAS遺伝子野生型であれば

- ✓ セツキシマブ(cetuximab, Cmab)

- ✓ パニツムマブ(panitumumab, Pmab) +¥454,660/月

- EGFR(: 上皮成長因子受容体)に対する阻害薬

- 腫瘍に発現している表面抗原を標的にした薬剤

¥559,120/月

¥739,140/月

- 1次治療: FOLFOX+BEV、FOLFOX+Pmab
- 2次治療: FOLFIRI+Cmab、FOLFIRI+BEV
- 3次治療: TAS-102+BEV
- 4次治療: レゴラフェニブなど

抗EGFR抗体薬は*RAS*遺伝子の変異状況で治療効果が予測できる

- *RAS*遺伝子野生型の腫瘍では、細胞内シグナルをコントロール可能で治療効果が期待
→セツキシマブ、パニツムマブを用いる
- 大腸癌では、約半数が野生型
- 手術標本、内視鏡生検から遺伝子変異を確認